Séminaire le 03 janvier 2020

Faculté de médecine
Université A-M, Béjaïa

Les déterminants émotionnels, la gravité, la chronicité et la décision en fin de vie

Auteur : BERRETIMA Abdel-Halim
Professeur de sociologie, Université de Béjaïa
Contact : aberretima@yahoo.com

I. LE PROCESSUS DE LA DEMANDE ET DES DÉTERMINANTS ÉMOTIONNELS

Introduction

Lorsqu'on chercher à identifier le processus de la demande et des déterminants émotionnels, on doit d'abord définir l'appréhension psychosociale à travers l'influence des émotions sur un comportement quelconque et ses troubles (Exemple le comportement à l'égard d'une maladie chronique).

Identifier une émotion

Une personne qui a de bonnes compétences émotionnelles peut identifier son agacement, sa tristesse, sa frustration, son stress.
Une personne qui a des difficultés en matière d'identification des émotions sait si elle se sent bien ou mal et les difficultés à identifier ce qu'elle ressent comme émotion.

Comprendre une émotion

Une personne qui comprend bien ses émotions est capable de faire la différence entre le déclencheur d'une émotion et sa cause.

Un exemple : toute émotion après une remarque quelconque. Le fait déclencheur de cette remarque (L’humeur, la fatigue, l’énervement ou le stress)

Une personne qui comprend bien ses émotions sait faire la différence entre le déclencheur et la cause.

L’utilité de l’émotion

La personne qui sait bien utiliser ses émotions peut apporter des changements à sa vie (ex. changer de travail ou partir en vacances).
La personne qui n'utilise pas ses émotions pourrait perdre des choses importantes dans sa vie.

Exprimer son émotion

Une personne qui exprime bien ses émotions peut facilement et calmement expliquer à son collègue de travail ou à son conjoint par exemple pourquoi elle n'est pas satisfaite de son comportement ou de sa réaction.

Une personne qui exprime mal ses émotions ne peut pas maîtriser sa colère et peut rentrer facilement en conflit avec les autres.

Réguler ses émotions.

Une personne qui gère bien ses émotions est capable de ne pas perdre ses moyens en situation de stress, de colère ou de jalousie.

Une personne qui gère mal ses émotions aura beaucoup de difficultés à poursuivre la tâche en cours en situation de stress, en criant, insultant ou même frappant (ex. crise de jalousie)

Les déterminants émotionnels en santé

L'influence des compétences émotionnelles sur la santé n'est que rarement étudiée de manière approfondie.

Si certaines études ont déjà été consacrées à l'influence des compétences émotionnelles sur la santé subjective, les indicateurs objectifs de santé (l'utilisation des soins de santé) ne sont que rarement évoqués.

Les déterminants émotionnels en santé

Les compétences émotionnelles sont liées de manière significative à la santé

En santé, il faudrait chercher le lien entre les compétences émotionnelles et les différentes formes d'utilisation des soins de santé (utilisation des médicaments, nombre de consultations chez un médecin, nombre d'hospitalisations…).

Les déterminants émotionnels en santé

Ces interactions significatives montrent que les compétences émotionnelles constituent un facteur déterminant de la santé.

A propos de l'utilisation des soins de santé, il s'est avéré que l'âge, le sexe, le niveau de formation, l'indice de masse corporelle (IMC), les émotions positives et négatives, le soutien social, les habitudes alimentaires et les habitudes en matière d'activité physique ont également montré un lien significatif avec la consommation de médicaments et l'utilisation des soins de santé.

Les compétences émotionnelles et l'âge sont les deux principaux facteurs prédictifs de la santé

II. IES DIMENSIONS DE LA GRAVITÉ ET DE LA CHRONICITÉ

- La chronicité s’inspire de tout ce qui est Chronique, c’est-à-dire une chose nuisible qui dure dans le temps.

- Lorsqu’il s’agit de maladie, celle-ci prend un caractère nuisible et durable pour la patient.

- L'évolution d’une maladie chronique progressive passe des phases d'aggravation successives.

- C’est ainsi que la gravité d’une maladie ne peut être mesurable dans sa dimension temporelle.

- Dans la définition de la chronicité, il existe donc un double rapport au temps et à la maladie pour se projeter dans une préfiguration de la mort.
- A la chronicité sont liées les conditions et les sentiments de désespoir, de résignation effrayante et accablante
- La gravité comme la chronicité, sont deux concepts qui se résument à l'impuissance du soignant, et à l’image de désespoir et de détérioration progressive, stigmatisant le patient.

- Face à la réalité de notre vie quotidienne, et en absence d’une guérison, différemment exprimée par des patients, des familles, ou des soignants, la chronicité nous impose de mobiliser des ressources parfois épuisables.

- Ceci demande un grand effort de formation aux professionnels concernés, plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique comme l'Alzheimer.

- Cette maladie est discutée comme un exemple de maladie chronique qui entraîne des handicaps évolutifs, s'aggravant progressivement sur de nombreuses années.

- L'existence d'éléments psychopathologiques rend parfois nécessaire un traitement psychiatrique.

- En définitive, la chronicité interpelle le thérapeute qui est obligé à se situer face à l'échec de l'acte médical rationnalisé.

III. LA DÉMARCHE DÉCISIONNELLE EN FIN DE VIE

Introduction

La démarche décisionnelle et l'accompagnement en fin de vie relèvent des enjeux du mourir. La fin de vie et les décisions qu'elle appelle, du lieu de la mort à venir (maison, hébergement, hôpital avec ou sans accompagnement des soins « palliatifs ») à ses modalités thérapeutiques (retrait du traitement) est synonyme d'incertitude chez le patient.

Cette incertitude prend effet lorsque la décision de poursuite ou d'arrêt de traitement implique non pas un choix pour soi mais bien pour autrui : un exemple, le médecin qui arrête les soins à son patient.

La décision à prendre pour la fin d'une vie

Les décisions à prendre peuvent avoir un moment de négociation avec la personne malade, sa famille, des pairs (cliniciens) ou des instances institutionnelles.

Il existe certains repères culturels, d'ethnicité et de croyances religieuses face à la mort, ce qui poserait un problème dans la décision des professionnels de la santé dans la conviction des patients et de leurs familles.

La décision à prendre pour la fin d'une vie

La fin de vie, c'est aussi une question d'accompagnement par les proches et par les soignants (exemple le Cancer). Les structures spécialisées dans l'accompagnement des personnes en fin de vie sont mises en place pour assurer des vocations palliatives, des établissements de soins généraux et des structures d'hébergement. Cet accompagnement mobilise différents acteurs « professionnels » (infirmière, médecin, travailleur social, psychologue, nutritionniste, kinésithérapeute, etc.) et des associations.